

Notes de lecture des 64 références

Préparation de la leçon probatoire HETS Genève · 5 juin 2026

Pierre Brasseur

NOTES DE LECTURE

Synthèse des 64 références mobilisées dans la leçon et le module

Fiches structurées en 5 champs pour chaque référence : *Thèse* · *Concepts* · *Citations* · *Exemple BA* · *Limite*. Les citations marquées « page à vérifier » devront être contrôlées sur l'édition utilisée avant projection.

VOLET 1 — MODÈLES THÉORIQUES DU HANDICAP

1.1 Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Macmillan.

Thèse. Le handicap n'est pas la conséquence directe d'une déficience corporelle mais le produit d'une organisation sociale qui exclut et opprime les personnes déficientes. C'est le « modèle social ».

Concepts. Distinction *impairment* / *disability* · modèle social vs individuel/médical · production sociale du handicap (capitalisme industriel) · oppression et idéologie validiste · émancipation collective.

Citations. « Disability is something imposed on top of our impairments by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society » (Oliver, reprenant UPIAS, 1990, p. 11). « It is society which disables physically impaired people. »

Exemple BA. Une personne en fauteuil ne peut pas accéder à un guichet du Service des prestations complémentaires : son « handicap » n'est pas dans ses jambes mais dans l'absence de rampe. Le TS doit interroger l'environnement avant la personne.

Limite. Oliver minore la souffrance corporelle et l'expérience subjective de la déficience (critique de Shakespeare, Crow, French).

1.2 Goffman, E. (1963/1975). *Stigma*. Minuit.

Thèse. Le stigma est un attribut socialement disqualifiant qui, dans l'interaction, transforme une personne « normale » en personne « entachée ». Les stigmatisés développent des stratégies de gestion d'identité.

Concepts. Stigma (corporel, de caractère, tribal) · identité virtuelle vs réelle · discrédité / discréditable · *passing* et *covering* · normaux / initiés / sages.

Citations. « La société établit les procédés de catégorisation des personnes et le complément d'attributs que l'on estime ordinaires et naturels » (1975, p. 11). « Par définition, nous pensons qu'une personne ayant un stigma n'est pas tout à fait humaine » (1975, p. 15).

Exemple BA. Un jeune adulte avec une déficience intellectuelle légère qui dissimule sa mesure de curatelle lors d'un entretien d'embauche : c'est le *passing*. Le TS doit comprendre ce coût identitaire avant d'exiger la « transparence ».

Limite. Approche micro-interactionniste : peu de prise sur les rapports de pouvoir structurels.

1.3 Wolfensberger, W. (1972/1983). Normalisation et VRS.

Thèse. Les personnes dévalorisées (déficience intellectuelle notamment) doivent accéder à des rôles sociaux valorisés et à des conditions de vie aussi proches que possible des normes culturelles dominantes.

Concepts. Normalisation (Nirje, Bank-Mikkelsen) puis Valorisation des Rôles Sociaux (VRS/SRV) · rôles sociaux valorisés · image sociale / compétences · conservatisme · désinstitutionnalisation.

Citations. « The most explicit and highest goal of normalization must be the creation, support and defense of valued social roles for people who risk devaluation » (Wolfensberger, 1983).

Exemple BA. Plutôt qu'un atelier occupationnel infantilisant, soutenir l'accès à un emploi adapté en milieu ordinaire et à un logement individuel : VRS appliquée au parcours d'un jeune adulte sortant d'une institution genevoise.

Limite. Normativité de la « culture dominante » : qui décide ce qui est « valorisé » ? Risque d'assimilationnisme (critique des Deaf Studies, *crip*).

1.4 OMS (2001). CIF — *Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé*.

Thèse. Le fonctionnement humain résulte de l'interaction dynamique entre fonctions organiques, activités, participation sociale et facteurs contextuels. La CIF substitue un modèle bio-psycho-social au modèle médical de la CIH (1980).

Concepts. Fonctions et structures organiques · activités / participation · facteurs environnementaux · facteurs personnels · modèle bio-psycho-social.

Citations. « Le fonctionnement et le handicap d'une personne sont le résultat de l'interaction dynamique entre son état de santé et les facteurs contextuels » (OMS, 2001, Introduction).

Exemple BA. Évaluation AI : un même diagnostic (sclérose en plaques) produit des « participations » très différentes selon l'accessibilité du logement et du poste de travail.

Limite. Compromis institutionnel onusien : la CIF reste très médicalisée dans ses usages réels.

1.5 Fougeyrollas, P. (2010). *La funambule, le fil et la toile*. PUL. MDH-PPH.

Thèse. Le handicap est une situation produite par l'interaction entre facteurs personnels, facteurs environnementaux et habitudes de vie. La situation de handicap n'est ni dans la personne ni dans l'environnement, mais dans leur rencontre.

Concepts. Situation de handicap (variable, contextuelle) · habitudes de vie · facteurs environnementaux (obstacles/facilitateurs) · processus de production du handicap · approche écosystémique.

Citations. « Le handicap n'est pas une caractéristique de la personne mais le résultat contextuel d'une interaction » (Fougeyrollas, 2010). Métaphore du funambule : la personne (funambule) avance sur un fil (habitudes de vie) tendu dans une toile (environnement).

Exemple BA. Un même jeune autiste sera « en situation de handicap » dans un open-space bruyant et « hors situation de handicap » dans un poste calme avec consignes écrites.

Limite. Modèle complexe, parfois difficile à opérationnaliser dans les dispositifs administratifs qui exigent des catégorisations fixes.

1.6 Nussbaum, M. (2006). *Frontiers of Justice*. Belknap/Harvard.

Thèse. Le contractualisme rawlsien échoue à penser la justice envers les personnes lourdement handicapées car il présuppose des contractants libres et productifs. L'approche par les capacités garantit à chacun un seuil minimal de dix capacités centrales.

Concepts. Dix capacités centrales · critique du contractualisme · dignité humaine non conditionnée à la rationalité · care et dépendance · justice pour les « cas marginaux ».

Citations. « A life worthy of human dignity » est garantie quand la société assure le seuil des dix capacités (Nussbaum, 2006).

Exemple BA. Une personne polyhandicapée sans communication verbale a droit à la capacité d'« affiliation » et de « jeu » : le TS qui accompagne en institution doit évaluer ces dimensions, pas seulement les soins de base.

Limite. Liste universelle critiquée pour son ethnocentrisme. Tension avec les approches *crip* qui refusent l'idée d'un seuil normatif d'humanité.

1.7 ONU (2006). *CDPH*.

Thèse. Premier traité international des droits humains du XXI^e siècle. Les personnes handicapées sont sujets de droits, non objets de charité. Les États doivent garantir accessibilité, autonomie, inclusion et non-discrimination.

Concepts. Approche par les droits (*paradigm shift*) · capacité juridique (art. 12) · accessibilité universelle (art. 9) · vie autonome et inclusion (art. 19) · aménagements raisonnables.

Citations. « Reconnaittent que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales » (Préambule, e). « Nothing about us without us » (esprit du processus de rédaction).

Exemple BA. La Suisse a ratifié la CDPH en 2014. Le TS peut s'en servir pour contester un placement institutionnel non choisi (art. 19) ou défendre la suppression de la curatelle de portée générale au profit de l'accompagnement à la décision (art. 12).

Limite. Effectivité variable. La Suisse a émis des réserves et le Comité CDPH a critiqué (2022) le retard sur l'institutionnalisation et la capacité juridique.

1.8 Stiker, H.-J. (1982/2013). *Corps infirmes et sociétés*. Dunod.

Thèse. Anthropologie historique du traitement social de l'infirmité. Chaque société construit un rapport spécifique. La modernité produit le paradigme de la « réadaptation » qui vise à effacer la différence par l'identique.

Concepts. Réadaptation comme paradigme moderne · effacement / identique · histoire longue des figures de l'infirmes · construction sociale de la déficience.

Citations. « Réadapter, c'est ramener à la norme, à l'identique, et c'est par là même désigner comme différent » (Stiker).

Exemple BA. Le paradoxe de l'inclusion scolaire : on intègre l'enfant en classe ordinaire (identique) tout en maintenant un dispositif spécifique (auxiliaire de vie) qui le re-désigne comme différent.

Limite. Approche très théorique et parfois schématique dans son découpage historique.

1.9 Revillard, A. (2020). *Des droits vulnérables*. Presses de Sciences Po.

Thèse. À partir de récits de vie, les droits sociaux issus des grandes lois sont « vulnérables » : leur existence formelle ne garantit pas leur effectivité, leur mobilisation dépend de ressources sociales inégalement distribuées.

Concepts. Réception des politiques publiques · droits vulnérables / effectivité · travail des bénéficiaires · inégalités d'accès aux droits.

Citations. « Les droits ne sont pas seulement ce que les textes disent, mais ce que les personnes parviennent à en faire » (Revillard, 2020). Les droits sont « vulnérables » car « leur mise en œuvre repose sur des configurations institutionnelles et des ressources individuelles fragiles ».

Exemple BA. Une personne ayant droit à une prestation AI mais qui ne sait pas remplir le formulaire, ne connaît pas les délais de recours, n'a pas accès à un avocat : son droit existe mais n'est pas effectif. **Le TS est un opérateur clé de cette effectivité.**

Limite. Centrée sur le contexte français (MDPH) : transposition au contexte suisse (AI, LHand) nécessite des médiations.

1.10 Ville, I., Fillion, E., Ravaud, J.-F. (2014/2020). *Introduction à la sociologie du handicap*. De Boeck.

Thèse. Manuel synthétique qui retrace la construction du handicap comme catégorie d'action publique, présente les principaux modèles, restitue les apports des *disability studies* et de la sociologie française.

Concepts. Construction sociale du handicap · modèles théoriques · catégories d'action publique · *disability studies* · expérience du handicap.

Citations. « Le handicap n'est pas un donné mais un construit historique, social et politique. »

Exemple BA. Boussole pour situer un dossier concret (ex. demande d'AI) dans les différents cadres : médical (diagnostic), administratif (taux), social (barrières), expérientiel (vécu).

Limite. Format manuel qui aplatit parfois les controverses internes au champ.

VOLET 2 — TRANSFORMATIONS CONTEMPORAINES

2.1 Comité ONU CDPH (2022). *Observations finales sur la Suisse*. CRPD/C/CHE/CO/1, 13 avril 2022.

Thèse. La Suisse demeure largement organisée autour d'une logique institutionnelle et médicale du handicap, en décalage avec le paradigme des droits humains. Recommandation d'un plan national de désinstitutionnalisation avec calendrier contraignant.

Concepts. Désinstitutionnalisation · vie autonome (art. 19) · capacité juridique (art. 12) · mainstreaming · harmonisation intercantonale.

Citations. « The Committee is concerned about the lack of a comprehensive deinstitutionalization strategy » (§ 41) · « adopt a deinstitutionalization strategy with a clear time frame » (§ 42).

Données. Absence de statistiques nationales consolidées. Inclusion Handicap : environ 40 000 personnes en home.

Exemple BA. Travailler sur l'écart entre droit international (art. 19) et pratiques quotidiennes en foyer genevois : exercice de repérage d'indices d'institutionnalisation dans un règlement d'établissement.

2.2 Mansell, J., & Beadle-Brown, J. (2010). « Deinstitutionalisation and community living ». *JIDR*, 54(2), 104-112.

Thèse. Position officielle IASSIDD. La désinstitutionnalisation n'est pas la simple fermeture des établissements mais la mise en place de services de proximité de qualité, individualisés. La qualité dépend de la conception, pas de la taille.

Concepts. *Community living* · *active support* · transinstitutionnalisation · *person-centred planning* · qualité de vie.

Citations. « Community-based services are typically associated with better outcomes than institutional provision, but outcomes vary widely depending on how services are organised » (p. 106).

Données. Synthèse internationale : les résidents en habitat communautaire ont des scores supérieurs en autodétermination, choix quotidiens, participation.

Exemple BA. Un foyer de 60 places se réorganise en 8 appartements de 4. Quels indicateurs de qualité au-delà de la simple « sortie de l'institution » ?

2.3 AGILE.CH (2023-2024). Dossier *Vie autodéterminée* + position désinstitutionnalisation.

Thèse. Lecture stricte de l'art. 19 CDPH : la Suisse doit cesser de financer prioritairement les places en institution et réorienter vers des prestations d'assistance personnelle.

Concepts. Vie autodéterminée · choix du lieu de vie · assistance personnelle · égalité de traitement · logique de droits vs logique d'offre.

Citations. « Le droit de choisir où et avec qui vivre n'est pas effectif tant que le financement reste lié à l'institution. »

Données. La contribution d'assistance ne touche qu'environ 3 000 bénéficiaires en 2022 — très en deçà du potentiel.

Exemple BA. Étude comparée du budget cantonal genevois : institutions vs prestations individuelles.

2.4 Inclusion Handicap (2022). Communiqué « *mauvaise note* ».

Thèse. Reprend les observations ONU. Dénonce le retard suisse en matière de désinstitutionnalisation, accessibilité, inclusion scolaire, autodétermination.

Données. Environ 50 % des enfants handicapés en Suisse fréquentent encore des écoles spécialisées ; majorité des adultes avec DI vivent en institution.

Exemple BA. Rédiger une note d'analyse pour un service social cantonal : ce que les observations ONU impliquent concrètement.

2.5 ENIL — *European Network on Independent Living*. Position papers.

Thèse. Defense du mouvement *Independent Living*. Ce ne sont pas les personnes handicapées qu'il faut « réhabiliter », mais l'environnement social, juridique, économique. L'assistance personnelle dirigée par l'utilisateur est l'instrument central.

Concepts. *Independent Living* · *user-led* / *peer-led* · *personal assistance* · *choice and control*.

Citations. « Nothing about us without us » (Adolf Ratzka). « Independent Living means having the same choices and control over our every-day lives as our non-disabled brothers and sisters. »

Données. Environ 1,5 million de personnes handicapées vivent encore en institution dans l'UE. ENIL documente l'usage de fonds structurels européens pour rénover des institutions.

Exemple BA. Analyser une offre d'emploi de « répondant-e d'unité » en institution vs un poste d'« assistant-e personnel-le » : quels rapports de pouvoir entre TS et personne accompagnée ?

2.6 Wehmeyer, M. (1996). « *Self-determination as an educational outcome* ».

Thèse. Modèle fonctionnel de l'autodétermination : agir comme l'agent causal principal de sa propre vie, sur la base de quatre caractéristiques.

Concepts. *Causal agent* · autonomie comportementale · autorégulation · *empowerment* psychologique · autoréalisation.

Citations. « Self-determined behavior refers to volitional actions that enable one to act as the primary causal agent in one's life. »

Données. Élèves ayant suivi un curriculum d'autodétermination (ChoiceMaker, Self-Directed IEP) : meilleurs résultats post-scolaires (emploi, vie autonome) à 1 et 3 ans.

Exemple BA. Élaborer avec un-e adulte en foyer un « plan personnel » fondé sur les 4 composantes. Différence entre « faire pour », « faire avec », « soutenir l'agentivité ».

2.7 Ryan, R. & Deci, E. (2017). *Self-Determination Theory*. Guilford.

Thèse. Trois besoins psychologiques fondamentaux universels : autonomie, compétence, appartenance. Leur satisfaction conditionne motivation intrinsèque, bien-être, engagement.

Concepts. Besoins de base · motivation intrinsèque / extrinsèque · internalisation · continuum de l'autodétermination · *autonomy support*.

Citations. « Autonomy, competence, and relatedness are not just preferences but universal psychological necessities » (p. 86).

Exemple BA. Grille d'observation d'une pratique d'accompagnement : la posture du-de la TS satisfait-elle les trois besoins ? Distinguer « contrôler », « contraindre », « soutenir l'autonomie ».

2.8 Lachapelle, Wehmeyer, Shogren (2022). *NREI*, 94(2).

Thèse. Articulation du modèle Wehmeyer avec une perspective développementale et écosystémique. L'autodétermination se construit tout au long de la vie. Ce n'est pas un trait individuel à entraîner mais un produit relationnel.

Concepts. *Causal Agency Theory* · écosystème · trajectoire développementale · opportunités d'apprentissage · aménagements environnementaux.

Données. Travaux du *Kansas University Center on Developmental Disabilities* (KU-CDD) : interventions *Self-Determined Learning Model of Instruction* (SDLMI).

Exemple BA. Cartographier l'écosystème d'un-e jeune en transition école-emploi (famille, école, OAI, employeur, foyer) et identifier les leviers d'autodétermination à chaque niveau.

2.9 HAS (2022). *Autodétermination, participation et citoyenneté* (TDI Volet 1).

Thèse. Recommandations de bonnes pratiques. L'autodétermination est posée comme principe organisateur, déclinée en droits effectifs.

Concepts. Accessibilité de l'information (FALC) · consentement éclairé · projet personnalisé · pair-aidance · transformation de l'offre.

Citations. « Reconnaître la personne comme experte de sa propre vie. »

Exemple BA. Réécrire en FALC le règlement d'un foyer. Exercice de design de service au plus près des préconisations HAS.

2.10 Jouet, E., Flora, L., Las Vergnas, O. (2010). *Pratiques de formation – Analyses*, 58-59.

Thèse. Cartographie pionnière des savoirs expérientiels développés par les patients atteints de maladies chroniques ou de troubles psychiques. Plaide pour leur reconnaissance institutionnelle.

Concepts. Savoir expérientiel · patient-expert · pair-aidance · tiers-savoir · co-production du soin.

Citations. « Les patients développent, au fil de l'expérience de la maladie, des savoirs spécifiques qui ne sont pas réductibles aux savoirs médicaux. »

Données. Dispositifs analysés : *Stanford CDSMP*, Université des patients Pitié-Salpêtrière.

Exemple BA. Discussion : peut-on construire un poste de pair-aidant-e dans un service social handicap genevois ? Conditions (statut, formation, supervision).

2.11 OFAS (2020). *Évaluation finale de la contribution d'assistance AI*.

Thèse. La contribution d'assistance, introduite en 2012, augmente l'autodétermination et la qualité de vie des bénéficiaires, mais sa diffusion reste limitée par la complexité administrative et la concurrence du financement institutionnel.

Concepts. Contribution d'assistance AI · employeur-bénéficiaire · charge administrative · effets de seuil · alternative au home.

Données. Environ 2 600 bénéficiaires fin 2019 (cible initiale 3 000 dès 2012) · durée moyenne d'engagement d'assistants 41 h/semaine · satisfaction très élevée (81 %) · rares retours en home.

Exemple BA. Simuler l'accompagnement d'une personne dans la demande de contribution d'assistance : calcul des besoins, posture de tiers, articulation avec un service de relève.

2.12 Le Bihan, Da Roit, Sopadzhiyan (2019). *SPA*, 53(4), 579-595.

Thèse. Comparant France, Italie, Pays-Bas, les politiques de *cash-for-care* instituent un « familialisme optionnel par le marché ». Les familles restent productrices d'aide mais peuvent acheter du soin sur un marché concurrentiel — au prix d'une précarisation des aidants professionnels.

Concepts. *Cash-for-care* · familialisme optionnel · marchandisation du care · *care workers* migrant-es · régulation du quasi-marché.

Exemple BA. Débat : la contribution d'assistance suisse présente-t-elle les mêmes risques de précarisation ? Lecture critique d'une convention d'engagement d'assistant-e.

2.13 Glendinning, C. (2008). *SPA*, 42(5), 451-469.

Thèse. Analyse des *direct payments* et *individual budgets* en Angleterre : changement de paradigme vers une logique de choix et contrôle individuels. Promesses (autodétermination) mais risques (inégalités d'accès selon la capacité à gérer).

Concepts. *Direct payments* · *individual budgets* · *personalisation* · *choice and control* · *care management*.

Citations. « Personalisation marks a shift from the citizen-as-recipient to the citizen-as-purchaser of care. »

Données. Pilotes *Individual Budgets Evaluation Network* (IBSEN) 2008 : effets positifs sur le bien-être des adultes handicapés mentaux, plus mitigés chez les personnes âgées.

Exemple BA. Comparer modèle anglais et contribution d'assistance suisse : qui assume le rôle de *care manager* ? Quel rôle pour le-la TS dans un système de budget individuel ?

2.14 Plaisance, É. (2009). *Autrement capables. Autrement.*

Thèse. Plaidoyer pour une école et une société qui reconnaissent les personnes handicapées comme « autrement capables » plutôt que déficitaires. Passage d'une logique d'intégration (l'élève s'adapte) à une logique d'inclusion (l'école s'adapte).

Concepts. Intégration vs inclusion · capacités · reconnaissance · école pour tous.

Citations. « Reconnaître les personnes handicapées comme autrement capables, c'est cesser de les définir par ce qu'elles ne peuvent pas. »

Exemple BA. Repérer dans le discours d'un-e enseignant-e ou éducateur-trice les marqueurs d'une logique d'intégration (déficitaire) vs d'inclusion (capacitaire).

2.15 Ebersold, S. (2017). *L'éducation inclusive. PUG.*

Thèse. L'éducation inclusive ne se réduit pas à scolariser des élèves handicapés en classe ordinaire. Elle suppose une transformation du système éducatif. Sans cette transformation, l'inclusion devient un privilège réservé à ceux qui disposent des ressources familiales et sociales pour la négocier.

Concepts. Accessibilité pédagogique · gouvernance inclusive · trajectoires · transitions · inégalités sociales du handicap.

Citations. « L'inclusion scolaire ne tient pas ses promesses si elle reste affaire de mobilisation familiale. »

Exemple BA. Cartographier les ressources mobilisées par une famille genevoise pour obtenir une mesure d'aménagement scolaire. Discussion : quelle équité ?

2.16 Piérart, G. (dir.) (2013). *Handicap, famille et migration. IES.*

Thèse. L'intersection handicap-migration : les familles migrantes confrontées au handicap d'un enfant cumulent des obstacles linguistiques, juridiques, culturels. Sous-représentation dans les dispositifs d'aide précoce. Plaidoyer pour une intervention socio-éducative interculturelle.

Concepts. Intersectionnalité handicap/migration · non-recours · intervention précoce · médiation interculturelle · représentations culturelles du handicap.

Exemple BA. Étude de cas : accompagner une famille primo-arrivante avec un enfant porteur de polyhandicap dans l'accès aux droits AI. Repérer les zones de non-recours.

2.17 Masse, M. et al. (2018). *Accessibilité et participation sociale*. IES, HETS Genève.

Thèse. Articulation entre accessibilité (transformer l'environnement) et participation sociale (être partie prenante de la vie collective). Mobilisation du MDH-PPH pour analyser des dispositifs suisses romands.

Concepts. MDH-PPH · situation de handicap · accessibilité universelle · participation sociale · facteurs environnementaux.

Données. Études de cas suisses romands (transports, formation, logement). Mobilisation de la *Mesure des habitudes de vie* (MHAVIE). Projet impliquant 47 institutions romandes et environ 7 000 adultes avec DI.

Exemple BA. Audit d'accessibilité d'un service social genevois : signalétique, accueil, documents, posture professionnelle.

2.18 Pachoud, B. & Corbière, M. (2014). *L'Évolution psychiatrique*, 79(3), 365-381.

Thèse. Le rétablissement (*recovery*) n'est plus défini comme absence de symptômes mais comme reconstruction d'une vie sociale et professionnelle. Les dispositifs probants (emploi accompagné IPS, remédiation cognitive, pair-aidance) restent peu diffusés en francophonie.

Concepts. Rétablissement · emploi accompagné (*Individual Placement and Support*, IPS) · remédiation cognitive · pair-aidance · participation sociale en santé mentale.

Citations. « Le rétablissement est un processus singulier, non linéaire, qui ne se confond pas avec la guérison clinique. »

Données. Méta-analyses IPS : 55-60 % de mise à l'emploi compétitif vs 20-25 % pour les programmes *train-then-place*.

Exemple BA. Cas : un-e usager-ère sortant d'hospitalisation veut reprendre un emploi. Construire un accompagnement IPS — articulation OAI, employeur, équipe soignante, pair-aidant.

VOLET 3 — POSTURE PROFESSIONNELLE

3.1 Clot, Y. (1999). *La fonction psychologique du travail*. PUF.

Thèse. Le travail n'est pas seulement gagne-pain ou aliénation. Il a une fonction psychologique structurante, à condition que le travailleur puisse y déployer son « pouvoir d'agir » et inscrire son activité dans une histoire de métier (genre professionnel).

Concepts. Activité réelle vs travail prescrit · genre professionnel / style · pouvoir d'agir · empêchement · clinique de l'activité.

Citations. « Le travail bien fait est ce qui permet au sujet de se reconnaître dans ce qu'il fait. »

Exemple BA. Un éducateur contraint par des protocoles standardisés qui l'empêchent de prendre le temps de l'écoute : son « activité empêchée » nuit à la qualité de l'accompagnement et à sa propre santé.

Limite. Conceptualisation parfois jargonneuse. Dispositifs (autoconfrontation croisée) difficiles à mobiliser en formation initiale.

3.2 Clot, Y. (2008). *Travail et pouvoir d'agir*. PUF.

Thèse. La santé au travail dépend de la capacité du collectif à élaborer le « réel de l'activité ». Quand le genre professionnel s'effrite, le pouvoir d'agir se réduit et la souffrance s'installe.

Concepts. Réel de l'activité (vs activité réalisée) · pouvoir d'agir · genre / style · collectif de travail · qualité empêchée et conflits de critères.

Citations. « La santé, c'est la possibilité d'agir sur son milieu et sur soi-même. » « Ce qui rend malade au travail, ce n'est pas le conflit, c'est l'impossibilité du conflit. »

Exemple BA. Une équipe d'AS qui n'a plus de temps de supervision collective perd la possibilité de discuter les dilemmes : c'est un appauvrissement du genre professionnel.

3.3 Lipsky, M. (1980/2010). *Street-Level Bureaucracy*. Russell Sage Foundation.

Thèse. Les agents de terrain (enseignants, policiers, travailleurs sociaux) qui appliquent les politiques publiques au contact des usagers disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable. Ils sont les véritables *policy makers* qui transforment la politique en pratiques.

Concepts. *Street-level bureaucracy* · pouvoir discrétionnaire · routinisation et stéréotypisation · *coping mechanisms* (rationnement, écrémage, simplification) · politique publique « par le bas ».

Citations. « The decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the devices they invent to cope with uncertainties and work pressures effectively become the public policies they carry out » (1980, p. xii).

Exemple BA. Un AS de l'AI qui traite 80 dossiers par mois doit développer des routines : c'est à ce niveau micro que la politique du handicap se décide réellement. L'éthique du TS est aussi politique.

3.4 Dubois, V. (2010). *La vie au guichet*. Économica.

Thèse. Ethnographie des interactions au guichet. Le guichet articule contraintes bureaucratiques, demandes sociales, travail relationnel. L'agent oscille entre rôle administratif et rôle social, tension constitutive.

Concepts. Relation administrative · double rôle · travail de mise en forme bureaucratique · inégalités face à l'administration · ethnographie du guichet.

Citations. « Les agents du guichet font face à des publics qui ne maîtrisent pas les codes administratifs et qui attendent autant un service qu'une écoute. »

Exemple BA. Un guichet du Service des prestations complémentaires à Genève : la personne handicapée vient pour un formulaire, mais raconte aussi sa vie. Le TS doit gérer ce double registre.

3.5 Paperman, P., Laugier, S. (dir.) (2006/2011). *Le souci des autres*. EHESS.

Thèse. Recueil fondateur en français qui introduit les *care ethics* anglo-saxonnes. Le care n'est pas un sentiment privé mais une activité, un travail, une éthique et une politique qui révèlent la dépendance constitutive de tous les humains.

Concepts. Care comme activité (*caring about, taking care of, care giving, care receiving*) · éthique du care vs éthique de la justice · vulnérabilité et dépendance · travail invisible du care · politique du care.

Citations. « Le care est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre "monde" » (Tronto, citée dans le recueil).

Exemple BA. Le travail d'auxiliaire de vie auprès d'une personne tétraplégique (toilette, repas, déplacements) est un travail de care historiquement invisibilisé, féminisé, sous-payé.

3.6 Tronto, J. (2009). *Un monde vulnérable*. La Découverte.

Thèse. Tronto déplace le care de l'éthique privée vers la philosophie politique. Une démocratie *caring* reconnaît que la vulnérabilité est universelle et redistribue les responsabilités de care au lieu de les confiner aux femmes, aux racisé-es, aux pauvres.

Concepts. Quatre phases du care (+ cinquième : *caring with*) · frontières morales · privilèges d'irresponsabilité · démocratie *caring* · vulnérabilité ontologique.

Citations. « Nous sommes tous des êtres vulnérables et dépendants. Il s'agit de redistribuer la responsabilité du care, non de la concentrer sur les plus faibles » (Tronto, 2009).

Exemple BA. Reconnaître que tout le monde aura besoin de care à un moment (enfance, vieillesse, accident) renverse la stigmatisation de la dépendance dans le champ du handicap.

3.7 Schön, D. (1983/1994). *Le praticien réflexif*. Éditions Logiques.

Thèse. Les professionnels compétents ne se contentent pas d'appliquer des savoirs académiques (rationalité technique). Ils mobilisent un « savoir caché dans l'agir » et conduisent une *reflection-in-action* et *reflection-on-action* qui leur permet d'affronter incertitude, singularité, conflits de valeurs.

Concepts. Rationalité technique vs réflexion en action · *knowing-in-action* / *reflection-in-action* / *reflection-on-action* · praticien réflexif · « conversation avec la situation ».

Citations. « Les praticiens compétents en savent généralement plus qu'ils ne peuvent en dire » (Schön, 1983). *Reflection-in-action* : « penser à ce qu'on fait pendant qu'on le fait ».

Exemple BA. Un éducateur face à une crise comportementale d'un usager avec trouble du spectre autistique : aucun protocole ne dicte la réponse exacte. Il « dialogue avec la situation », ajuste, observe, puis débriefe en équipe.

3.8 Hochschild, A. (1983). *The Managed Heart*.

Thèse. Dans l'économie de services, les travailleurs doivent produire des émotions appropriées au rôle attendu. Ce *travail émotionnel* est exploité par les employeurs et produit des coûts subjectifs (dissonance, aliénation émotionnelle, burn-out).

Concepts. Travail émotionnel (*emotional labor*) vs *emotion work* · *surface acting* / *deep acting* · règles de sentiment (*feeling rules*) · aliénation émotionnelle.

Citations. « This labor requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the outward countenance that produces the proper state of mind in others » (1983, p. 7).

Exemple BA. Une AS qui doit annoncer un refus AI doit « gérer » sa propre frustration et produire empathie + neutralité institutionnelle. Travail invisible dans les fiches de poste mais central et coûteux psychiquement.

3.9 Perske, R. (1972). « The Dignity of Risk and the Mentally Retarded ». *Mental Retardation*, 10(1).

Thèse. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont droit à prendre des risques ordinaires (travailler, aimer, voyager, se tromper). Les surprotéger au nom de la sécurité revient à leur dénier leur dignité.

Concepts. Dignité du risque · surprotection comme déni de dignité · apprentissage par l'expérience · autodétermination.

Citations. « There can be such a thing as human dignity in risk. And there can be a dehumanizing indignity in safety! » (Perske, 1972).

Exemple BA. Une jeune femme avec trisomie 21 qui veut prendre seule le tram pour aller travailler : l'équipe oscille entre risque (se perdre) et dignité (autonomie). Perske invite à accompagner le risque plutôt qu'à l'empêcher.

3.10 Charlton, J. (1998). *Nothing About Us Without Us*. University of California Press.

Thèse. Manifeste du mouvement international des droits des personnes handicapées. Aucune décision concernant les personnes handicapées ne doit être prise sans leur participation directe.

Concepts. *Nothing about us without us* · oppression validiste · *empowerment* individuel et collectif · *disability rights movement* · conscience politique du handicap.

Citations. « Nothing about us without us! » « Disability oppression is a totalizing system » (Charlton, 1998).

Exemple BA. Une commission cantonale qui révisé les prestations handicap sans inviter de personnes concernées : contradiction directe. Le TS peut être l'allié qui pousse à inclure des représentant-es d'AGILE.CH.

VOLET 4 – TRAVAUX DE PIERRE BRASSEUR

4.1 Brasseur, P. (2024). *Sociologie de l'assistance sexuelle*. PUF, 276 p.

Thèse. Enquête sur l'émergence et l'institutionnalisation de l'assistance sexuelle en Europe francophone (Suisse, Belgique, France). Elle se constitue comme zone-frontière entre travail du care, travail du sexe et politiques du handicap.

Concepts. Assistance sexuelle (vs accompagnement, vs prostitution) · frontières morales et professionnelles · sexualités handicapées · travail intime / travail du care · politiques de l'autonomie sexuelle.

Citations. L'assistance sexuelle se situe « à la frontière du travail social, du travail du sexe et du soin ». Elle met en tension « droit à la sexualité » et « marchandisation du corps ».

Exemple BA. En Suisse, l'association SEHP forme des assistant-es sexuel·les. Un éducateur en institution genevoise peut être sollicité pour informer un résident de cette possibilité : posture professionnelle complexe entre droit à la sexualité, cadres institutionnels et convictions personnelles.

Limite. Question ouverte : l'assistance sexuelle reconduit-elle des rapports de genre et de classe dans le travail du care ? L'ouvrage problématise sans trancher.

4.2 Brasseur, P. & Rodriguez, J. (2019). *Participations*, 22(3), 139-158.

Thèse. Analyse des dispositifs participatifs traitant de la sexualité des personnes handicapées. Malgré la rhétorique participative, une division du travail épistémique persiste : les personnes handicapées sont mobilisées comme *témoins* tandis que les valides occupent les positions d'*experts*.

Concepts. Division épistémique témoin / expert · participation et ses limites · savoirs expérientiels vs savoirs académiques · sexualités handicapées · production des savoirs et rapports de pouvoir.

Citations. « Les personnes handicapées sont invitées à témoigner de leur expérience pendant que les valides en produisent l'analyse » (2019). La participation se déploie selon « une économie inégale de la parole ».

Exemple BA. Dans une journée d'étude HETS sur sexualité et handicap, vérifier qui parle dans quelle position : une personne handicapée invitée pour témoigner 10 min en ouverture et 3 universitaires valides en plénière de 90 min illustrent exactement cette division.

4.3 Brasseur, P., Robert, L. & Garré, B. (R1 acceptée, 2026). *Sexual violence against children with disabilities*. *Social Science and Medicine*.

Thèse. Documente les angles morts institutionnels dans la prise en charge des violences sexuelles subies par les enfants en situation de handicap : prévention insuffisante, sous-signallement, parcours de soin défailants.

Concepts. Violences sexuelles · *care worker responses* · institutionnal pathways · angles morts professionnels · prévention.

Exemple BA. Articulation entre droit à la protection (CDPH art. 16 : protection contre l’exploitation, la violence et la maltraitance) et droit à l’intimité (art. 22). Le TS doit naviguer ces deux exigences.

VOLET 5 – CONTEXTE SUISSE ET GENEVOIS (synthèse opérationnelle)

5.1 Cadre légal fédéral

- **Constitution fédérale art. 8 al. 2 et 4 + art. 112b.** Base constitutionnelle de l’interdiction de discrimination et de l’intégration des personnes invalides. En vigueur depuis 2000.
- **LHand (RS 151.3).** Loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (2002, en vigueur 1.1.2004). **Révision partielle adoptée par le Conseil fédéral le 20 décembre 2024** : extension aux prestataires privés, en discussion au Parlement 2025-2026.
- **LAI (RS 831.20).** Trois piliers : rentes ; réadaptation professionnelle ; **contribution d’assistance** (introduite 1.1.2012). Logique *cash-for-care*.
- **LIPPI (RS 831.26).** Subventions fédérales aux institutions. Art. 7 : les cantons participent aux coûts de séjour.
- **CDPH ONU.** Ratifiée par la Suisse **le 15 avril 2014**, en vigueur 15 mai 2014.

5.2 Cadre légal cantonal genevois

- **LIPH-GE (K 1 36).** Loi cantonale (2003, en vigueur 1.1.2004). Instaure les EPI.
- **LIMAD (K 1 07).** Loi sur l’imad (18 mars 2011).
- **Plan cantonal genevois CDPH** : volume 1 publié **janvier 2023**.
- **Avant-projet LED-H** (Loi sur l’égalité et les droits des personnes handicapées) : en consultation depuis le **12 juin 2024**, co-construit avec ~40 organisations.

5.3 Initiatives politiques 2024-2026

- **Initiative populaire « Pour l’inclusion ».** Déposée 5 septembre 2024. **107 910 signatures validées sur 109 110.** Demande l’inscription constitutionnelle de l’égalité, de la participation, de l’autodétermination, et du droit à l’assistance personnelle.
- **Contre-projet indirect du Conseil fédéral** : première mouture juin 2025 ; **message adopté le 25 février 2026** — jugé en-deçà des attentes du comité d’initiative.

5.4 Acteurs institutionnels (Genève)

Acteur	Statut	Rôle
Département de la cohésion sociale (DCS)	État	Tutelle politique
OAIS — pôle handicaps	DCS	Mise en œuvre opérationnelle
Commission cantonale d’indication (CCI)	DCS	Orientation vers les EPH
OAI-GE imad	État Établissement autonome de droit public	Application LAI au niveau cantonal Maintien à domicile, 4 centres
SCOPSE	État	Contrôle qualité des EPH

5.5 Faïtières et associations

- **INSOS Genève** : faïtière des institutions. Président **Jérôme Laederach**. Comité : Jaugey (Foyer-Handicap), Rossetti (Centre Espoir), Bertrand (Aigues-Vertes), Biollay (Argos), Calabro (Arcade 84), Gisler (Trajets), Kolly (Clair Bois), Labhardt (Cap Loisirs).

- **fégaph** : 22 organisations membres.
- **Pro Infirmis Genève** : consultation sociale, conseil spécialisé, intervention sur assurances et droits sociaux.
- **Cap-Contact** : association romande de droits avec axe domicile.
- **Inclusion Handicap** (Berne) : faîtière nationale.
- **AGILE.CH** (Berne) : faîtière des organisations de personnes handicapées (45 orgs, créée 1951).

5.6 Grandes institutions et fondations genevoises

Fondation	Public	Spécificité
Fondation Ensemble	DI · ~250 personnes	Direction Laederach. Cinq structures de la petite enfance à l'âge adulte.
Fondation Aigues-Vertes	DI · ~120-137 résidents	Bernex. 21,5 ha.
EPI	Polyhandicap, DI, mental	Anthroposophique. Créée 1961. > 2 000 personnes/an. > 40 lieux dans le canton.
Fondation Clair Bois	Polyhandicap	Enfants, adolescents, adultes.
Fondation Foyer-Handicap	Handicap physique	Adultes.
Cap Loisirs, Trajets, Argos, Arcade 84, Centre Espoir	Divers	Acteurs cantonaux importants.

5.7 Projet emblématique : Sureaux

Habitat mixte coopératif inclusif à Chêne-Bougeries. Partenariat **Codha + Fondation Ensemble**. Chantier démarré septembre 2018, emménagement mars 2021. **19 logements dont 3 réservés à Ensemble (~12 résidents avec DI)**. Soutien BFEH. **1er prix d'innovation Coopératives habitat Suisse** catégorie « partenariat ». Cas d'école romand d'habitat inclusif.

5.8 Écosystème de recherche HETS

- **CERES**. Centre de recherches sociales. 5 axes (trajectoires, expériences des publics, rapports au corps, pratiques professionnelles, politiques sociales). **Pôle d'expertise Handicap**.
- **Réseau de compétences « Autonomie-Handicap-Dépendance » HETS-GE** : animé par Catherine Lenzi.
- **GIS Hybrida-IS** : réseau international (2016). 23 équipes, ~90 chercheur-es.

5.9 Chercheur-es HETS et HES-SO à connaître

- **Manon Masse** : autodétermination, prévention de la maltraitance, habitat, CDPH. Direction de *Accessibilité et participation sociale* (Éditions ies 2018).
- **Chloé Souesme** : habitat, déficience intellectuelle, pair-aidance.
- **Yves Delessert** : co-auteur des recherches Masse.
- **Geneviève Piérart** (HETS Fribourg) : handicap interculturel, familles, surdit .
- **Catherine Lenzi** : domicile, care, désinstitutionnalisation, autonomie discr tionnaire. **Direction (avec Alexandre Moine) de Des pas de c t  dans le travail social, Champ social 2025, 272 p.**
- **Barbara Lucas** : non-recours, droits politiques en EMS, citoyenn t .

Notes de lecture compil es le 29 mai 2026   partir des recherches men es par trois agents de recherche et des recherches compl mentaires de l'auteur. Citations   rev rifier sur les  ditions utilis es avant projection.